

INDICADO POR: Dr. Mario Jorge

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIZ ROBERTO CABRAL VILELA

IDADE: 44 PESO: 72 ALTURA: 170 PROFISSÃO: Contabilista (aposentado)

SINTOMAS: cansado / sonolento (após almoço) / RGE /

Falta de ar (durante o sono)

QUEIXAS:

(Depressivo se sente inútil desde 2012)

MEDICAMENTOS:

IAM (1 mamaria 2006) Aneurisma de aorta (fez cirurgia, não resolveu)

MÉDICO: —

Tem uma medula na coluna

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

protese da aorta

EXERCÍCIO FÍSICO: Todos os dias.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (18:30)

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 7-8h

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S (X) MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Parou 2006

TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 39,5

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 22.4 SPO2: 85% - (med 94%)

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Fibrose Pulmonar / IDO = 23,2/h

Nódulo na tireoide / (Hernia Disco há muitos anos) (PA elevada)

CIRURGIAS: (X) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: memória ruim.

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: (Dome DS)

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

22/10/25

medicamentos: Benicar / Crestor / Lipolil / AAS /

Avaliação

CCL associado a APNEIA
DO SONO

orge

3

de Neurologia

rofisiologia Clínica

Society

rsidade de São Paulo (USP)

lo HC - FMUSP

ANA CLAUORA

Eucarello o Sr. Luiz
Roberto e pedido de
SAOS avaliados p/
me avaliar e em
de CPAP

ateuco + fe

Mário Silva Jorge
Neurologia
CRM 27123

INEP - Instituto do Cérebro - Clínica da Memória
Rua Santa Clara, 450 - Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Telefones: (12) 3921-2071 / 3202-8050 / 3921-4177
Celular: (12) 99125-7193 - WhatsApp

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUIZ ROBERTO CABRAL VILELA			
Sexo: M	Idade: 73 anos	Peso: 71 Kg	Altura: 1.70 m
IMC: 24.6	Data do Exame: 14/03/2024	Exame: 13291_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:10 PM horas e encerrado às 5:43:53 AM horas, com latência para o sono de 6 minutos e latência para o sono REM de 247 minutos. O tempo total de sono foi de 378.0 minutos, com eficiência do sono de 88.7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2.4%	Até 5%
Estágio 2	65.9%	45 - 55%
Estágio 3	19.3%	> 15%
Sono REM	12.4%	20 - 25%
Eficiência do sono	88.7%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 41.5 minutos ocorreram **239 despertares (índice de 37.9 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 53 bpm, a maior de 61 bpm e a menor de 46 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 141 eventos respiratórios, sendo 0 central, 141 obstrutivos e 0 misto. Sendo 101 apnéias, 40 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 22.4/hora**, sendo 16.0 apnéia/hora e 6.4 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 27.3 e a duração máxima de 46.4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 58.7/hora, sendo 53.6 apnéia/hora e 5.1 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%**, sendo a saturação **média de 94%**, a **maior de 98%** e a **mínima de 85%**, permanecendo 0.9 minutos (0.2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 143 dessaturações. Índice de dessaturações: 23.2/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 60.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 18.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200